

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN MANAJEMAN AKTIF KALA III		
	No. Dokumen 739/I-SPO/DIR/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 29 Mei 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Penatalaksanaan manajemen aktif kala III adalah tindakan yang dilakukan setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban.	
Tujuan	Untuk menghasilkan uterus Yang efektif sehingga dapat mempersingkat waktu, mencegah perdarahan dan mengurangi kehilangan darah pada kala 3 persalinan.	
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 109/RSPH/I-PER/DIR/V/2015 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan bidan.	
Prosedur	1. Persiapan. 1) Alat : a. Alat pelindung diri b. S spuit 3 cc sebanyak 1 buah. c. Oksitosin 10 IU sebanyak 2 ampul d. Kasa secukupnya. e. Dekatkan alat ke pasien 2) Pasien. a. Lakukan komunikasi secara terapeutik pada pasien. b. Jelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan. c. Jelaskan pada pasien tujuan dari manajemen aktif kala d. Posisikan pasien secara litotomi. 3) Lingkungan. Ciptakan suasana aman dan nyaman (Tutup Tirai) 4) Pakai alat Perlindungan Diri. a. Gunakan tutup kepala / nurse cup Hair . b. Gunakan kaca mata bening. c. Gunakan masker. d. Gunakan scort (celemek) plastic. e. Gunakan sepatu boot. 5) Pelaksanaan. a. Lakukan Cuci tangan dan pakai sarung tangan steril. b. Berdiri disamping kanan pasien. c. Letakkan bayi baru lahir diatas kain bersih yang telah disiapkan di perut ibu dan minta ibu atau pendampingnya untuk membantu memegang bayi.	

PENATALAKSANAAN MANAJEMAN AKTIF KALA III

No. Dokumen
739/I-SPO/DIR/V/2024

No. Revisi
00

Halaman
2 / 3

- d. Pastikan tidak ada bayi lain di dalam uterus.
- e. Jelaskan kepada ibu bahwa akan disuntik.
- f. Berikan Segera suntikkan oksitosin 10 iu secara intramuskuler
- g. Lakukan tindakan penjepitan dan pemotongan tali pusat. Setelah 2 menit dari penyuntikan oksitosin,
- h. Serahkan bayi yang telah terbungkus kain pada ibu untuk inisiasi menyusui dini dan kontak kulit dengan ibu.
- i. Tutup kembali perut ibu dengan kain bersih.
- j. Pindahkan klem (penjepit untuk memotong tali pusat saat kala 2) pada tali pusat sekitar 5 – 10 cm dari vulva.
- k. Letakkan tangan kiri pada abdomen ibu (beralaskan kain) tepat di atas simfisis pubis.
- l. Gunakan tangan kiri untuk meraba kontraksi uterus dan menekan uterus pada saat melakukan peregangkan pada tali pusat. Setelah terjadi kontraksi yang kuat, regangkan tali pusat dengan satu tangan dan tangan yang lain (pada dinding abdomen) menekan uterus ke arah lumbal dan kepala ibu (dorso – cranial).
Lakukan secara hati – hati untuk mencegah terjadinya inversio uteri.
Bila plasenta belum lepas, tunggu hingga uterus berkontraksi untuk mengulangi kembali penegangan tali pusat terkendali dan jika sudah 15 menit berikan injeksi oksitosin 10 IU im yang ke 2 .
periksa kandung kemih , lakukan kateterisasi jika penuh.
- m. Tegangkan tali pusat ke arah bawah, lakukan tekanan dorso – cranial hingga tali pusat makin menjulur dan korpus uteri bergerak ke atas yang menandakan plasenta telah lepas dan dapat dilahirkan saat ada kontraksi uterus akan menjadi bulat atau tali pusat terlihat bertambah Panjang dan terasa adanya pelepasan plasenta
(jika plasenta 15 menit ke 2 plasenta belum lahir lakukan tindakan manual plasenta).
- n. Lahirkan plasenta dengan mengangkat tali pusat ke atas dan menopang plasenta dengan tangan lainnya
Pada saat plasenta terlihat pada introitus vagina.

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN MANAJEMAN AKTIF KALA III		
	No. Dokumen 739/I-SPO/DIR/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	o. Pegang plasenta dengan kedua tangan secara lembut putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin menjadi satu. p. Lakukan penarikan dengan lembut dan perlahan – lahan untuk melahirkan selaput plasenta. q. Lakukan pengecekan pada plasenta dan selaput plasenta dengan menggunakan tangan kanan, apakah telah lahir secara lengkap/ tidak. plasenta yang telah lahir diletakkan dalam wadah penampung r. Lakukan massase pada fundus uteri dengan menggosok fundus secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi baik (fundus teraba keras). s. Periksa kemungkinan adanya perdarahan pasca persalinan. 1) kelengkapan plasenta 2) kontraksi uterus . 3) perlukaan jalan lahir jika ada robekan lakukan hecting. t. Dekontaminasi dan Rapikan peralatan . 1. Lakukan Dokumentasi.		
Unit Terkait	1. Maternitas 2. PONEK		